

Lp(a)·아포B — 2026년에 새로 보는 혈관 위험 검사

콜레스테롤(LDL)과는 별도로 혈관 위험을 보여주는 두 가지 혈액검사입니다. Lp(a)는 타고난 유전 수치, 아포B는 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 개수를 반영합니다.

한눈에 보는 핵심 수치

유전 기여도

90% ↑

운동·식사로 거의 변하지 않음

LP(A) 낮음

<75

nmol/L (75~125 경계)

LP(A) 위험 증가

≥125

nmol/L (≥250 위험 2배↑)

검사 권장

평생 한 번

성인기 — 경계치·상태 변화 시
재검 고려

두 검사가 각각 보는 것

LP(A) — 유전으로 정해지는 수치

90% 이상 유전으로 정해지는 지질 입자로, LDL 콜레스테롤과 따로 측정합니다

운동이나 식사를 바꿔도 크게 변하지 않아 **평생 한 번** 검사합니다

높다면 **부모·형제자매·자녀**도 검사를 상담해 보세요

위험 기준(nmol/L): 75 미만 낮음, 75~125 경계, 125 이상 위험 증가(위험 증강 인자), 250 이상은 위험 2배 이상입니다.

결과지 단위가 mg/dL이면 이 숫자와 바로 비교하지 마세요.

아포B — 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 수

LDL을 포함해 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자마다 하나씩 붙는 단백질입니다

작고 치밀한 LDL이 많을 때 LDL 콜레스테롤 수치보다 위험을 더 잘 보여줄 수 있습니다

아포B/아포A1 비율이 남성 0.9 이상, 여성 0.8 이상이면 심혈관 위험이 높은 쪽으로 봅니다(연구에서 제안된 기준)

LDL 수치가 정상이어도 아포B가 높으면 남은 위험이 있을 수 있습니다

결과가 높다면

함께 관리하는 것

이 결과를 참고해 **약을 쓸지 말지, 저강도·중강도·고강도 스타틴 중 어떤 것을 쓸지, 목표 LDL을 얼마나 정할지**를 진료에서 함께 정합니다

금연은 특히 중요합니다

혈압·혈당 등 다른 위험요인도 함께 확인합니다

정기 진료로 전체 혈관 위험도를 재평가합니다

아직 정해지지 않은 것

Lp(a)만을 낮추는 용도로 승인된 치료제는 **아직 없고, 여러 약이 임상 3상 시험 중**입니다

지금은 **LDL 콜레스테롤과 다른 위험요인**을 더 철저히 관리하는 것이 표준입니다

Lp(a) 관리를 위해 영양제·보충제를 복용하는 것은 권장하지 않습니다

운동만으로 수치가 크게 떨어지지는 않습니다

이럴 땐 바로 응급실로

Lp(a)·아포B 수치가 높다는 것 자체는 응급 증상이 아닙니다. 다만 갑자기 심한 가슴 통증, 팔다리 마비나 힘 빠짐, 말이 어눌해짐, 심한 호흡곤란이 있으면 결과 설명을 기다리지 말고 바로 응급실로 가시거나 119에 연락하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 EAS Lp(a) 합의문 · 한국지질·동맥경화학회 Lp(a) 입장문 2026 · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 가이드라인 · 2024 NLA 아포B 임상 컨센서스 · apoB/A1 AMORIS(Walldius 2004)

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 목표 수치와 약물 선택은 전체 위험도, 기존 질환, 가족력에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/lpa-apob/

